

採血 <前編>

透析患者は乏尿・無尿のため本来腎臓から排出される老廃物が体内（血中）に蓄積していく。

透析患者の体内は特殊状態。

週3回の透析で老廃物は除去されるため血中濃度は大きく変化。

検査値を評価する場合はどのタイミング（透析前、透析後）で採血したかが重要。

みたきでは月一回の定期採血を行っている。

●採血項目（※基準値はみたき透析室における目安）

☆Hb（ヘモグロビン）

基準値：10～12（g/dL）

貧血の指標。

主に腎性貧血（エリスロポエチン産生低下）の影響でHbは低値になる。

→透析中の血圧低下や日常生活において動悸・息切れにつながる。

腎性貧血以外のHb低下の原因

- ・出血による貧血（急激な Hb の減少は消化管出血を疑う）
- ・鉄欠乏性貧血（フェリチン、TSAT を確認）
- ・その他（白血病など骨髄性の貧血、ビタミン B 12 欠乏、葉酸欠乏など）

☆WBC（白血球）

基準値：9000（個/ μ L）以下

主に感染症や炎症で上昇。

☆Plt（血小板）

基準値：15～40(万個/ μ L)

HIT（ヘパリン起因性血小板減少症）では急激に低下するため注意。

☆フェリチン

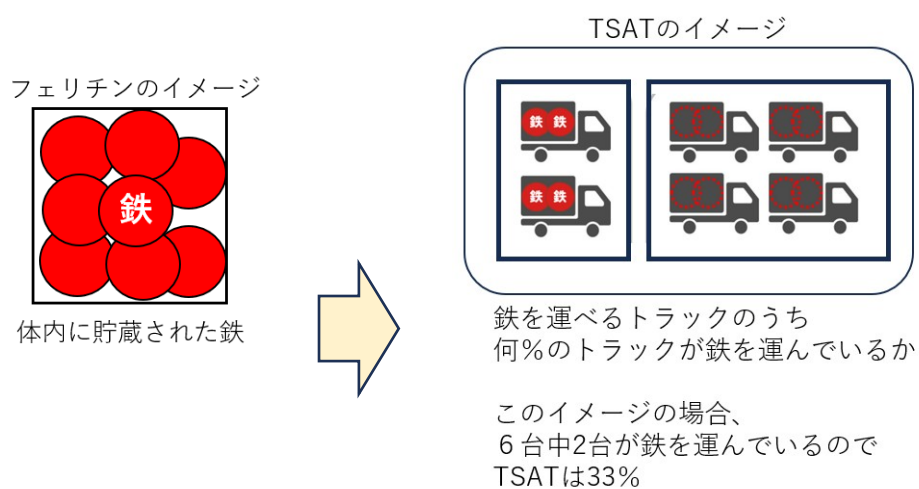
基準値：100～300（ng/mL）

体内の貯蔵鉄の指標。

☆TSAT（ティーサット）

基準値：20（％）以上

貯蔵鉄がどの程度、体内に運ばれているかを示す指標。



ESA 投与下で目標 Hb 値が維持できない患者において、

推奨：血清フェリチン値が 100ng/mL 未満かつ TSAT が 20%未満の場合、フェジン投与を検討。

☆hanp（ハンプ）

基準値：25～100(pg/dL)

DW の指標。

詳細は「DW」資料参考。

内容に関する質問や意見等は ME 伊藤までお願いします。